讲师与办公室交接｜待机构审阅

基准 2023-03-01 10:00 Asia/Shanghai。面向研究人员、学生及科研管理人员；业务/案例/SOP 原创，政策来自真实冻结来源。12 情境均未取得伦理批准或开研授权。

一、讲前必须纠正的旧稿

T1 两办法并行：2016 十一号令为部门规章；2023 统一制度指导实践，医疗机构违规可据 11 号令处理，不写全面废止。（S03 第七问；S01 第 45–49 条）

T2 适用主体：2023 覆盖医疗卫生机构、高等学校、科研院所等；不是仅医院，也不因学生作业自动排除。（S02 第 2–3 条）

T3 一般/简易：一般会议审查；符合简易条件可由主任委员指定两个或以上委员，意见不一致等须转会议。（S02 第 15/31 条；S01 第 24 条仅作旧规范对照）

T4 免审不是免同意：第 32 条有无伤害/无敏感个人信息或商业利益等前提；匿名化不等去标识化。2016 医疗机构适用范围内的免除签署制度与免除伦理审查不同，不能由 32 条自行免签。（S02 第 32/33 条；S01 第 39 条（医疗机构范围））

T5 多机构：牵头与参与机构均应组织伦理审查，参与机构还需跟踪；可依法采用简易确认，不直接拿牵头意见替代。（S02 第 27/31(四)条）

T6 委托：书面委托有能力的机构或区域委员会；医疗机构还需不低于本机构等级的医疗委员会或区域委员会，受托须跟踪。（S02 第 5/14 条）

T7 知情同意：限制/无民事行为能力者需监护人书面同意，同时在参与者可理解范围告知并征得其同意，不能只收签字。（S02 第 34 条）

T8 时间和上传：受理后 30 天内开展审查并出意见；紧急情况及时，疫情突发一般 72 小时，不降低质量；获批研究实施前各主体上传并及时更新。（S02 第 16/24 条）

T9 备案起点：新设委员会设立后 3 个月备案；既设委员会过渡 6 个月、既获批研究 9 个月分别按第 54 条起点，不混为一条。年度报告每年 3 月 31 日前。（S02 第 13/54 条；S01 第 14/50 条）

T10 变化再审：批准后修改方案/同意书/招募等须提交审查；未授权同事无权替委员会批准或覆盖负责人受控补充。（S02 第 23/30 条；S05/S06 原创权限）

二、讨论组织与关键追问

先由学员判断“缺证/候选/需组织审查”，再追问依据、缺口和下一责任人。委员会依法决定，秘书只汇总/核形式。免审候选交机构核定是 S08 内部培训操作，不假称条文直接授予秘书此权。

A | 补风险资料，未定程序：补风险与科学性等申请材料，由委员会判断程序，秘书不得从无干预推定最小风险。

B | 免审候选，交机构核定：给定前提可提出 32(一)免审候选，按本团队流程交机构核定；不是秘书已作伦理批准。

C | 未证匿名化，不直接免审：保留映射钥匙不能当已匿名；补数据可识别性/来源/用途资料，不直接免审。

D | 简易候选，至少两委员：符合给定小改/不影响风险受益条件，可申请简易，由主任指定两个或以上委员并向会议报告。

E | 转会议审查：简易中委员意见不一致，转会议审查；不得按多数或主任单签强过。

F | 本机构审查并跟踪：牵头已批不代本机构审查/跟踪；可依法走参与机构简易确认，不能直接开研。

G | 书面委托有能力委员会：独立企业可书面委托有能力机构委员会或区域委员会，受托需跟踪；不编企业医院等级要求或伪造已受托。

H | 委托等级不符，重新选择：拟受托医院等级低于委托方，改选不低等级的有能力医疗委员会或区域委员会；书面委托、跟踪及本机构设委责任均待落实。

I | 补参与者告知与同意：除监护人书面同意外，还须在参与者可理解范围告知并征得其同意；本题未完成，不宣布可入组。

J | 商业利益，不按 32 条免审：不能仅因公开/匿名主张第 32 条免审；提交机构按事实核定审查路径。

K | 既设委员会过渡备案：既设委员会按 54 条过渡 6 个月办理并上传，不套新设 3 个月；不在未核发布起点时伪算精确截止日。

L | 新设委员会三个月备案：新设委员会按设立起 3 个月备案/上传；医疗向执业登记机关，其他按隶属向上级主管；年度报告另看 3 月 31 日。

三、真实依赖工作流和范围

重建命令：python3 workflow.py build --input-dir /app/input_files --output-dir /app/output --work-dir /tmp/med003-new-run。使用一个尚无 state.json 的新工作目录，保留旧运行证据。验证：python3 workflow.py verify --input-dir /app/input_files --output-dir /app/output --work-dir /tmp/med003-new-run。stage S5 等只在前置完成且哈希一致时可运行。

S0 冻结 10 输入；S1 规则与 S2 受控事实并行依赖 S0；S3 须两者合并；S4 教学口径依赖规则；S5/S6/S7 分别生成工作簿/课件/讲师说明；S8 勾稽三产物；S9 只签发内部待审回执。J 按有权 R2 为“商业利益，不按 32 条免审”，晚到无权便笺不能覆盖。快照/节点/产物任一被改，verify 必须拒绝；重新构建不得沿用旧 receipt。

变更责任：培训负责人核业务补充，伦理办公室核法规/程序，讲师同步全部课件，研究负责人补实际审查材料。后台备案/上传、临床安全、机构执业/能力、参与者知情同意实际取得与专家签字均未执行。未给完整事实不裁定临床风险/适当性，不伪造审批。

时点：2016 公布 10 月 12 日/起施 12 月 1 日；2023 通知落款 2 月 18 日，自发布起施；2 月 27 日为官方解读发布日期，不据此冒称通知准确发布时刻。不把公报下载地址 2023/202305 或后期上传文件名当法律起算；具体过渡截止日未要求、未伪算。K 在 2 月 1 日设立、L 在 3 月 1 日设立，分别位于前/后明确范围；若新案例落在落款与已知公开解读之间，应转核准确起点而不是机械分类。

S01/S02 为官方公报页面节选，保留原印刷页码；S02 首提取页上方可能含前一条公报尾段，不属于本办法。S03 为官方索引原文转录而非已下载原 HTML，直连 412 已披露。取证 2026-10-20，不是 2023 现场记录或授权。